

常見督導議題（二）：技術面的困難

對應原書：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. 第5章 Handling Common Technical Supervisory Issues (pp. 107–140)

本檔內容：學習目標 | 完整學術摘要 | 核心概念洞見 | 關鍵原文引述 | 臨床推理框架

標示說明：「原教材指出」表示內容直接來自原書；「從臨床實務角度」表示本教材的延伸詮釋。原書的 Exhibit 5.1–5.5 在此改寫重構，不逐字翻印。原書督導示例已由作者改寫以保密，本教材只摘述其教學重點。

本單元學習目標

完成本單元後，你能夠：

1. 能判別一段受督者的困難陳述屬於概念、知覺或行動困難（或個案概念化、個人化困難），並規劃相應的任務環境。〔分析／反思實務〕
2. 能區分第一層批評與第二層（教練式）批評，並在雙椅片段中寫出引導個案抵達第一層批評的介入語句。〔應用／介入〕
3. 能在空椅微技巧片段中，指出換椅時機、「此刻感覺到什麼」、先憤怒後悲傷、「我」語言等錯誤，並依個案的核心需求（依附或受侵犯）提出修正順序。〔評鑑／介入〕
4. 能辨識自己作為受督者時的自我批評與害怕深化，說明其與個案恐懼之間的循環關係，以及哪些部分屬於督導、哪些屬於個人治療。〔評鑑／反思實務〕
5. 能說明「介入是手段而非目的」，在多重標記並存時以核心痛苦決定方向，並避免領先太多或只提供洞察。〔應用／介入〕
6. 能從一份個案資料中，把次發的絕望與核心痛苦分開，並逐步修正暫定的概念化。〔分析／概念化〕
7. 能提出一項依個人風格調整 EFT 任務步驟的方案，並評估它是否仍然符合 EFT 原則。〔創造／反思實務〕

§2 完整學術摘要

A. 主題與背景

為什麼技術困難特別關鍵

原教材指出，EFT 督導中的困難，常出現在技術層面。受督者一旦在促進個案良好歷程時卡住，就會很快感到氣餒：開始懷疑跟隨歷程、同理調頻情感與喚起性介入是否有幫助，並被拉向問題解決與給建議。

具體來說，困難常出現在執行介入上，因為有大量複雜的介入與微技巧要學。督導的很大一部分，是處理受督者以符合模式的方式執行介入時遇到的困難。這是必要的，因為特定的介入歷程已被證實能預測較佳的結果（Greenberg, 2010）。

督導在技術面要達成的事

- 協助受督者克服對情緒的恐懼，以及使用同理與喚起性介入的阻礙；對某些受督者來說，這些介入看起來不夠以解決問題為導向。
- 協助受督者維持探索與發現的姿態，而不是權威的姿態。
- 維持整體的歷程導向姿態，本身往往就能幫助受督者在技術上更熟練。
- 示範什麼是歷程導向、活在當下、把手指放在個案的情緒脈搏上，是協助受督者發展跟隨歷程態度的最佳方式。做法是聽治療錄影，並逐刻教學。

本章的三個領域

1. 個案概念化的困難；
2. 概念化與執行介入的困難：概念、知覺、行動三類；
3. 讓技術面向個人化、以適合受督者的困難。

B. 個案概念化的困難

B1. Exhibit 5.1：個案概念化困難的任務（改寫重構）

成分	內容
標記	受督者感到不清楚、「卡住」，或覺得在理解個案的核心基模及其影響上漏掉了什麼；或個案的合作不穩固
任務環境： 澄清困難	督導者試著釐清受督者卡在哪裡，理解什麼說不通
任務環境： 概念理解	請受督者提供自己對個案困難的理解；督導者協助受督者在概念層次理解個案的運作模式
任務環境： 任務探索	雙方就個案的核心基模對話；督導者探索受督者對個案核心痛苦的感覺；在更具體的層次上，引導受督者理解個案的情緒基模，以及經驗的非適應性
受督者歷程	提供情境脈絡，或個案經驗中更多鮮明與痛苦的例子；聽片段時辨識原發與次發情緒，區分適應與非適應；辨識核心情緒、敘事與關係主題；書面寫下概念化
解決	對個案的核心情緒基模，以及它在核心衝突關係基模中的角色，有更好的理論理解；對概念化感到更清楚；能把逐刻歷程凝鍊為基模式的理理解

原教材補充的做法：督導者可能提問，協助受督者用更具體、情境化的語言說出概念化，或找出能闡明概念化的晤談例子。督導者也可能請受督者在下次督導前，寫下向個案表達概念化的方式，並在下次治

療前與督導者一起檢視。解決包括受督者對概念化的清楚感，以及向個案傳達概念化、提供焦點的好方式。

B2. 原書示例：概念化困難（幼兒園老師）

背景：受督者有碩士學位、受過一些 EFT 訓練。個案是幼兒園老師，曾兩度嚴重憂鬱，都發生在與尚未交往、但她已有感情的男性分開之後。她先前接受過治療，覺得有進步，因為那位治療師激勵她振作、再試一次。這次發作的誘因，是透過網路交友認識的男性結束了關係。雖然她對他不太有興趣，主要把這當作學習網路交友的方式，結束後卻陷入嚴重憂鬱。她覺得這是第三次失敗的關係，自己一定有很嚴重的問題，沒什麼希望。她已請病假數月，智識功能良好，面對困難感受時傾向理智化。治療師前兩次晤談了解背景，基本上同理地跟隨她，她因此稍微敞開、輕鬆了一些。

階段	發生了什麼	督導重點
標記	受督者說不清楚怎麼處理這位個案，找不到焦點	—
第二次晤談	第一次晤談時，她說原生家庭很好、父母很愛她；第二次卻說母親總是太擔心，讓她覺得只能做母親安心的事，免得母親擔心。她覺得被困住，「像被剪了翅膀的鳥」，同時又很罪惡	她以聚焦的聲音、帶著停頓與猶豫說出「被困住」，接著嘆了口氣，才說覺得罪惡。這在治療師聽來很觸動
督導者提問	督導者問受督者：你覺得對她來說什麼最重要？受督者說：罪惡感	罪惡感重要，但顯然有與母親的未竟事務。督導者再問：「你最被什麼觸動？」受督者：她說被困住的方式。督導者也覺得這很鮮明：這份感受若被追隨，會指向核心情緒基模
絕望	晤談後段，她為 35 歲還沒有真正的戀愛經驗感到悲傷，開始無望，說自己對人生不太在乎、大多時間躺在床上	督導者說明：她的無望是次發的症狀性情緒，需要協助她觸及底層的核心痛苦
第一個共構的概念化	她感到無望，因為看不出有誰會愛她；核心上她覺得不可愛	尚不清楚這是斷線時的焦慮不安全，還是以羞愧為基礎的無價值感
重新概念化	下一次晤談後：她感到無望，是因為發現自己會因為不理解的原因退縮；在追隨自己活力的感受（興趣與享受）時，感到困惑、不安全。她似乎無法把情緒當作資訊來使用。母女關係在這個動力中很重要，但仍在背景中	決定等待清楚的未竟事務標記出現在晤談中，再處理母親；目前最重要的是處理她對感受的理智化
第四次晤談結束時	追隨她的痛苦，抵達核心非適應性感受：基本的不安全，源於一位焦慮的母親缺乏支持，而母親需要的保護比她能給的更多	雙方很清楚：她受焦慮不安全所苦，這與童年必須避免任何讓母親焦慮的事有關，導致她謹慎、害羞，選擇退縮而不是冒險

階段	發生了什麼	督導重點
替代路徑	—	若她的罪惡感更強烈、持久，歷程可能會發展成處理她對母親未解決憤怒的自我中斷，而不是處理焦慮不安全

教學要點（從臨床實務角度）：這個示例示範了三件事：

- 用受督者的「觸動」當作羅盤；
- 把次發的絕望與核心痛苦分開；
- 概念化是逐步修正的，而且保留替代路徑。

C. 介入的困難：三個類別

原教材指出，EFT 督導者常遇到幾類介入困難：概念困難；知覺、傾聽與跟隨的困難；以及行動或介入的困難（做什麼、怎麼做、何時做）。

C1. 概念困難

核心：受督者需要在概念層次理解介入。

- 原書示例：雙椅對話的目的，是活化批評的聲音以喚起經驗；處理未竟事務的目的，是處理情緒。它不是練習如何在真實世界對他人說話的角色扮演。
- 受督者也需要理解不同介入歷程的一般步驟。這透過教學與閱讀達成。

Exhibit 5.2：概念困難的任務（改寫重構）

成分	內容
標記	受督者對某個 EFT 任務的概念或程序表達不確定、不清楚或不理解。例如：「為什麼我要活化批評者？我們不是要擺脫這個情緒嗎？」
任務環境：澄清困難	督導者聽出以下領域的概念困難：介入的結構、步驟的順序、如何活化適當的歷程、如何深化情緒、如何調節情緒
任務環境：處理概念困難	重述理論與研究背景，補上缺漏的理論；回答概念問題；提供軼事式例子，或一起看好的與不好的介入錄影；聽晤談片段，回饋並舉例說明可以用的不同介入；請受督者在督導外補足知識
受督者歷程	釐清主要的概念困難領域；回想背景理論，記下參考資料與想法；檢視自己或他人的介入時，找出困難並提問；觀察並評論治療師的表現；自行觀看更有經驗的治療師的介入錄影
解決	對某個概念或理論模式感到更清楚；把閱讀與臨床情境連結到概念，擴展知識

C2. 知覺、傾聽與跟隨的困難

微標記的定義：原教材指出，微標記是對個案瞬間表達或行為的觀察，它是一個介入的機會。例如一聲嘆息、一個皺眉、一句鮮明的話，都是把個案注意力引向當下經驗的機會。

做法：辨識出受督者知覺上的問題標記之後，例如錯過太多線索，或沒有察覺個案標記的出現，督導者與受督者進行任務探索。

- 一起聽錄影片段，逐刻暫停；
- 督導者鼓勵受督者聚焦注意力，試著辨識個案的微標記，同時擱置其他擔憂；
- 接著逐刻想像個案可能在經驗什麼，辨識不同的微標記，以及個案的經驗與處理風格。

Exhibit 5.3：知覺、傾聽與跟隨困難的任務（改寫重構）

成分	內容
標記	受督者表達擔憂：難以保持調頻於個案的經驗而非話語內容；難以理解此刻個案發生了什麼；難以「聽見」底下的情緒；難以掌握個案經驗的核心。督導者也可能注意到這些
任務環境：澄清困難	督導者聽出以下領域的困難：辨識個案的微標記；辨識特徵風格標記；辨識投入模式；辨識主要任務標記；辨識治療焦點的指標
任務環境：任務探索	一起聽錄影、逐刻暫停；建議聚焦注意、搜尋個案標記，擱置其他擔憂；辨識不同的標記，以及個案的經驗與處理風格
任務環境：練習治療回應	督導者用不同方法，協助受督者以有幫助的回應跟隨個案
受督者歷程	練習「成為個案」：聽一句個案陳述時，覺察個案可能的經驗；練習傾聽並辨識不同的治療標記；發展焦點；熟悉並分析、評分其他治療示例，使用經驗量表與情緒喚起量表；檢視治療示例，評估個案的情緒生產性（注意、符號化、一致性、接納、調節、主體性、分化）；練習促進情緒覺察與符號化的回應；練習處理情緒調節困難的介入
解決	受督者發展出較清楚的焦點，能辨識並區分個案的標記；更能把傾聽技能類推到更複雜的情境；更有效率地回應個案的標記

C3. 行動困難

核心：在各種同理與情感調頻之外，發展更進階的介入（例如椅子工作、意象），讓受督者有工具處理 EFT 特有的不同治療任務。

- 標記：受督者表達或隱含對「接下來做什麼、怎麼做」的擔憂；描述自己卡住、無法再幫個案、缺乏技術，或不知道該往哪個方向。
- 原書示例：一位傾聽與同理回應能力已經很好的受督者，抱怨對某位個案沒有進展，不知道接下來要「做」什麼。督導者會以她既有的技能為基礎，透過示範與練習不同治療任務的步驟來教她。這裡的督導標記是受督者在歷程中卡住的感覺，因此特定的督導需要浮現：學會如何協助個案投入新的介入。
- 所有介入的目標之一都是取用核心情緒基模，所以督導者常介入，協助受督者發展活化情緒的技能。

Exhibit 5.4：行動困難的任務（改寫重構）

成分	內容
標記	受督者表達對下一步做什麼或怎麼做的擔憂；描述自己「卡住」、無法幫助個案、缺乏技術，或猶豫該往哪個方向
任務環境：澄清困難	督導者調頻於受督者在同理本位、關係、再處理或重新演出任務上的困難
任務環境：任務探索	請受督者提供特定任務困難的具體例子；一起聽片段，任一方需要指出困難時就暫停；督導者以「可以做」而非對錯的概念工作，指出此刻可以做的替代方式；聚焦任務中的特定困難；雙方逐刻探索受督者的表現，以及在特定任務、任務中某一步驟、流暢融合等方面的困難；有可能的治療阻礙時，督導者深化受督者的經驗
任務環境：練習治療回應	請受督者思考不同的介入選項；督導者用不同方法協助受督者練習
受督者歷程	摘要個案概念化，建立脈絡；重述個案的核心情緒與主要治療焦點；聽治療片段，在自己困難出現時暫停；摘要並規劃下次可能的介入；帶回新介入的嘗試結果，與督導者一起檢視，直到熟練、流暢；學習特定治療任務，鞏固對步驟的理論理解；觀看督導者建議的特定任務錄影
解決	受督者在使用不同介入時越來越熟練、流暢

D. 介入困難的督導示例

D1. 受督者的自我批評

現象：原教材指出，介入督導中出現的主要困難之一，是受督者的焦慮或缺乏自信，導致對能力的自我懷疑與自我批評。這一切都會妨礙學習，尤其是做中學。

原書示例：受督者與一位 31 歲、有社交焦慮的男性個案晤談時，覺得很難讓個案轉向內在。聽錄影時，他們看到很多受督者錯過的深化機會。受督者說（意譯）：「我應該在這裡更聚焦他的羞愧，以及那是什麼感覺。我想當時我腦中在考慮要不要做椅子工作，所以分神了。我知道我需要更能讓他進到內在。我想有時候他的語氣和他的話很不一致，讓我困惑該怎麼回應。」

原教材的評論：自我批評常出現在有能力且敏感的治療師身上。

督導者的做法：

情況	做法
一般	正常化焦慮（帶一點幽默地說：「本來就很難完美，反正也沒有完美的方式。」）；肯定能力（「你做得很好！」）
自我批評持續時	在認知層次稍微拆解受督者的批評者，走過自我批評對話的早期步驟，凸顯受督者正在做什麼；但不會輕易進行治療，或針對受督者羞愧的內在經驗或其來源做雙椅對話，因為此刻的督導契約不包含個人工作

情況	做法
若似乎適合	討論受督者是否覺得個人工作會有幫助，如何進行，需要時提供轉介
較長期的阻礙	督導者可能在受督者有治療阻礙時做經驗性工作，有時做雙椅；但更常以同理探索處理，觸及對表現的焦慮或概念上的困惑

學雙椅時的焦慮：例如受督者對啟動個案兩邊的對話、加深分裂感到焦慮。督導的互動序列可能包括：

- 以更具體的方式探索困難（晤談中發生了什麼）；
- 處理困難，例如釐清治療師想學什麼：如何向個案介紹雙椅、如何在個案的經驗中建立分離與接觸、如何協助個案取用底層感受；
- 深化受督者對困難的感覺，例如處理並理解受督者的困惑與「治療阻礙」；
- 建議如何設置兩邊。

D2. 害怕深化

現象：原教材指出，一個需要反覆處理的重要困難，是受督者害怕進入個案最痛苦的感受，也就是害怕深化歷程。

原書示例：聽錄影時，受督者清楚看到：個案對讓自己進入痛苦之處有真實的衝突，害怕會卡住，無法在晤談後把自己拼回去，沒有人可以幫他收拾，沒有「安全網」。個案的自我中斷歷程阻止他放下保護、深入投入治療。治療師不太敢「推」個案，所以尋求協助。在這個脈絡中，「推」是指做自我中斷的工作：請個案換到另一張椅子，演出阻止自己進入痛苦的那一方。

受督者的恐懼：害怕破壞同盟、害怕失去個案，也擔心個案承受不了痛苦。原教材指出，這是督導中常出現的重要問題：受督者對痛苦情緒的恐懼。

督導者的做法：

1. 先確認沒有深化個案經驗的禁忌；
2. 驗證受督者的恐懼；
3. 引導受督者停留在情緒中，而不是迴避，協助他克服自己的迴避；
4. 協助受督者覺察自己對情緒的恐懼，教他中斷這份恐懼，鼓勵他學會忍受自己的情緒，這樣才能幫個案忍受個案的情緒。

界線：EFT 督導者不會活化受督者痛苦、令其畏懼的情緒，而是把這視為受督者經驗性訓練或與自己治療師的工作範圍。

循環歷程：受督者克服自己的恐懼後，更能幫助個案面對痛苦，並讓個案經驗到自己不會像害怕的那樣崩潰。這是一個循環：受督者在晤談中克服停留並深化情緒的恐懼，反過來幫助個案克服個案的恐懼。

- 當然，仍需要判斷痛苦情緒應該多快、多直接，或多慢、多間接地被接近、忍受與接納。
- 兩個層次的心理教育有幫助：督導者對受督者，以及受督者對個案。
- 更重要的是：受督者最能幫助個案面對痛苦情緒的方式，是受督者自己面對過痛苦情緒，發現自己活了下來，並經驗到自己是怎麼做到的。經驗性學習對協助受訓者學習處理情緒、給他們勇氣幫助個案做同樣的事至關重要。如前所述，這通常要在督導之外進行，也就是在受督者的訓練或治療中。

D3. 處理羞愧

困難：受督者的一個重大困難，是個案第一次揭露羞愧經驗之後，不知道怎麼繼續。

原書示例：督導者討論受督者在下次晤談主動提起這個內容的重要性，而不是迴避，因為迴避會證實這件事羞恥到無法談論。督導者建議受督者在下次晤談時說：他很高興個案信任他，信任到願意打破家規，告訴他父母的性行為、裸露與色情活動。下一次晤談，治療師提起這個羞恥經驗，讓雙方可以繼續處理。當治療師試著了解這些如何在情緒上影響個案時，個案說自己非常卡住。他一輩子接收到的訊息都是「這件事不存在」，所以不知道自己對公開的性與藥物有什麼感受。唯一能繼續下去的方法，是「閉嘴」，否認它影響了自己。

D4. 介入的彈性

現象：原教材指出，學過標記引導介入方法的治療師，常常太專注於找到正確的介入，在試圖執行介入時失去了個案的經驗。介入是抵達核心情緒的手段，本身不是目的。

原書示例：受督者說自己在晤談中迷失了，想太多下一步要往哪裡走。晤談中有多個標記（未竟事務、自我厭惡、自我中斷），很難知道何時往哪裡去。有幫助的概念化讓受督者看見：用哪個介入、跟隨哪個標記並不重要，只要治療師和個案抵達核心感受，並觸及個案對接納與驗證的需求。這讓受督者理解痛苦情緒的核心地位，並能回到跟隨個案的經驗、抵達核心的痛苦情緒。

D5. 教練式批評者：第一層與第二層批評

困難：原教材指出，大多數學習 EFT 的治療師都會遇到一個真正的困難：如何在雙椅工作中取得核心的批評聲音。這個歷程要求治療師協助個案抵達核心的負面自我評價，例如「你很笨／胖／醜／自私／是個失敗者」。這些是對個案人格的批評，而不是因為有症狀或問題而對自己的第二層批評。

	第一層批評	第二層批評
定義	核心的、針對性格的批評	因為有問題而批評自己
原書例子	「我沒有價值」（導致憂鬱） 「我很笨」（導致焦慮） 「我沒有需要的才能」（導致拖延）	「我好氣自己這麼憂鬱／焦慮／拖延」
治療師要做的	取得第一層批評	不讓個案停在為感覺糟而批評自己

原教材指出，即使受督者在概念上學過這一點，通常仍需要透過犯錯、並在督導中被指出來學習。

原書示例的教學重點：個案總是鞭策自己，覺得自己不完美、不成功、無助、是個魯蛇。她描述在家庭情境中無法堅持自己：與先生計畫外出，婆婆卻要大家留在家裡，她說了「都聽你的」，但其實想出去。

時刻	督導者的重點
批評者說「你為什麼不表達想法？控制一下你的想法！」	這是第二層的教練式批評者：她在批評自己不表達。真正的問題是她抑制自己，而不是她批評自己抑制自己。要找到阻止她表達的核心批評

時刻	督導者的重點
她說如果表達想法、結果出錯，就會被怪；她沒有把握、無法預測結果，所以猶豫	「所以你要說『過來這裡，讓她沒有自信』。」
批評者說「你在心裡太常批評別人……你這麼愛批評，他們會拒絕你。安靜。」	這是第一層批評：同時包含負面評價與嚇唬自己。要發展這兩者
治療師請她說「你總是在討好別人」	不太好。這又把她帶回教練式批評者：批評自己被抑制
治療師說「批評她，看著她的眼睛，她做錯了什麼？批評她」	這可能比較好，會得到更多第一層批評，例如你很笨、自私、醜等等

D6. 引導與教導：領先太多

困難：在同一事件中，另一個困難是引導與跟隨。治療師試圖引導個案改變，而不是跟隨個案的歷程。這常發生在急於促進改變、並把促進理解視為有幫助的治療師身上。

原則：

- EFT 的原則是：人必須先抵達一個地方，才能離開它。督導者雖然會引導，但只能領先一步，仍在個案的近側發展區內，所以治療師不能領先太多。
- 治療師無法用指令取得感受，只能跟隨並促進感受的浮現。
- 個案必須自我組織，以新的方式經驗自己，而不是理解某件事。
- 原教材把這稱為教 EFT 的「長久問題」：協助治療師成為對歷程敏感的新經驗促進者，而不是修改者、教導者或理解的提供者。

原書示例：治療師試圖喚起肯定性的憤怒作為個案恐懼的解藥，讓個案對抗批評的聲音，但時機不對：治療師領先太多，個案仍然在害怕。此外，受督者教導或詮釋以促進理解，但這並沒有促成新的經驗。

時刻	督導者的重點
治療師：「深呼吸。你有沒有一些憤怒？」	太早取用憤怒。個案的聲音、姿勢、話語中沒有任何憤怒的跡象。應該請她去製造焦慮的椅子，讓自己害怕
個案：「我沒辦法對他們生氣。」 治療師接著長篇解釋憤怒可以不針對任何人、可以是身體裡升起的憤怒，憤怒對她似乎很危險	需要讓她多做中斷，當她開始組織成肯定的自己時，再對抗壓抑者。而且你想促進的不只是洞察，也就是你在摘要中給的理解。雖然那很好，但你要讓她感覺到自己是在製造自己痛苦的能動者，讓身體投入，喚起「自己行動的受害者」的感覺，並促進對抗批評與中斷聲音的動機

D7. 引入自我中斷的雙椅

困難：原教材指出，處理自我中斷是督導中出現的最大困難之一。受督者難以看見中斷的歷程，也不知道如何介入。

時刻	督導者的重點
治療師反映：「你有感覺，但面對對你重要的人時，你就停在那裡，像結凍一樣，依對方的反應調整自己。」	「這時可以引入自我中斷的分裂。她在阻止自己。」
治療師說：「問題在這裡：你會依別人的反應阻止自己表達需要……你懂嗎？」	「你在提供理解、給她一個概念化，這很好。但你還需要創造一個經驗，超越理解。可以轉入中斷的對話。」
個案說自己一直在腦中想「應該那樣做」	「這是中斷／批評的歷程，需要介入。」
個案停下來：「我好像忘了要說什麼……像失憶。」	「這是當下的中斷。把它變成『在做』，而不是『被做』。」

D8. 未竟事務中的標記辨識

困難：有些受督者難以辨識正在浮現的標記。

原書示例：個案談到不被父母理解。她深吸一口氣，說有遺憾、失望、一些怨恨、有什麼缺了。她看起來悲傷而低落，聲音變低、變小；她似乎轉向內在尋找什麼，卻找不到；接著以變硬的聲音、撇嘴從中出來。

時刻	督導者的重點
上述的聲音與表情變化	「這是未竟事務的標記。以前出現過。現在就利用這個機會，和她的父母對話。」
治療師說「這個聲音是他們讓你內化的」	「現在是引入椅子對話的好時機：『過來這裡，做做看。』記得，你要幫她有一個經驗，而不只是洞察。你要她演出父母，並經驗到自己有能動性，能對抗她內在建構的父母。如你所知，這不是練習如何對真實世界的父母表現的角色扮演，而是重組她內在的自我—他人基模。」

D9. 未竟事務的空椅微技巧：進階受督者

原教材以一段對進階受督者的詳細督導，示範空椅對話的微技巧。督導者在督導前已看過錄影，受督者請求從個案與母親的未竟事務對話開始。原教材指出，受督者使用空椅時的兩大困難是：

- 請個案演出重要他人的負面（此例是忽視的他人）；
- 把空椅對話從敘事的描述（發生了什麼、當時感覺什麼）帶到當下的經驗（此時此地在此晤談中對對方的感受）。

以下整理督導者提出的十三條微技巧原則：

#	原則	督導者的重點（意譯摘述）
1	先建立經驗性接觸	不要從「把媽媽放在這裡，告訴她『我有點擔心（兒子）』」開始，那是從敘事開始。最好是：「把媽媽放在這裡。先，你看到她嗎？看到她時，你感覺到什麼？」若沒有浮現什麼，再讓她說其他事

#	原則	督導者的重點（意譯摘述）
2	小細節會累積	「我知道你很擅長這個。但這些雖然微小，卻都會累積。」
3	及早接住憤怒	她一開始就說了「我很生氣」。可以說：「看得到她嗎？告訴她『我很生氣』。」
4	避免評價性的語句	說「這聽起來很表面，你能從更深的地方說嗎？」即使語氣溫和，也可能讓她覺得被評判
5	太多敘事內容，要深化情緒	她基本上都在抱怨。最好把抱怨分化為底下融合的憤怒與悲傷
6	「你說這句話時，現在感覺到什麼？」	這能把她帶到經驗性的當下；相對地，談論她當時做了什麼、感覺什麼，較會引出認知處理
7	內容與歷程可能不同	她說「我覺得被忽視」，但她此刻的語調是怨恨。問「你說這句話時感覺到什麼？」能幫她連結到憤怒。有時反過來：內容是憤怒，當下的情緒卻是悲傷。「我此刻很生氣，因為我過去被忽視」。停在「你那時感覺到什麼？我覺得被忽視」，是敘事的第二層
8	不要太早換椅，否則變成辯論	她在抱怨時請她「過來，媽媽會怎麼說？」，會引出「你一直是個難搞的孩子」，變成母女辯論。兩個最好的選項：(a) 對話早期：「過來這裡，當那個忽視你的媽媽」，演出負面的他人；(b) 對話後期，觸及痛苦感受與深層需求之後：「過來這裡，媽媽怎麼回應你的感受和需要？」
9	演出個案心中的那個形象	個案心中有一個轉身離開、推開她、摀住耳朵的母親形象，要演出它，直到它在個案心中被活化，那就是核心情緒。受督者說看到的是讓人罪惡、責怪人的母親；理想的說法是：「過來這裡，當你那個責怪人的媽媽，責怪她。」不要變成「如果她打電話給媽媽會發生什麼」的角色扮演
10	把拒斥性憤怒轉為直接的「我」語言	她說「真可悲」，這是拒斥性的憤怒，是一種評判與厭惡。要取得的是賦能的憤怒與悲傷：「告訴她你氣什麼。」「你可以告訴她『我很生氣你』嗎？」要從「你」的責怪形式，移到「我」的表達形式
11	先憤怒，再悲傷，而且在當下	當人在抱怨時，憤怒與悲傷是融合的，通常要先取得憤怒，才能取得悲傷。若沒有先清出憤怒就去找悲傷，憤怒仍在敘事形式中，沒有被符號化、處理，悲傷就不會那麼深。督導者也說明：這是一個假設
12	憤怒中的需求 vs. 悲傷中的需求	憤怒中的是表層的需求，或與憤怒相連的需求；下一步是觸及原發的悲傷，以及悲傷中的深層需求與思念

#	原則	督導者的重點（意譯摘述）
13	依核心需求決定換椅時機	她最後一句是對母親的憤怒，此時換椅，就像婚姻中的爭吵，母親會辯護。若核心需求是親近，要先到悲傷。若母親曾有虐待，憤怒才是換椅的正確時機，因為那是適應性的、守護界線的回應。此例的核心是渴望與依附：「我需要你靠近，我很難過」，這會把母親拉近。所以當她說「我需要你」時：「再告訴她一次」「你說這句話時感覺到什麼？」「告訴她你思念什麼」

督導的結尾，受督者總結：「先憤怒，再悲傷。」督導者補充：「而且在當下。」

這段督導本身的示範（本章結論）：原教材指出，這位治療師在 EFT 上已經進階，需要的是精煉技能，而不是較不進階治療師需要的手把手陪伴。督導者也透過溝通，最後承認自己的誤解，預防了潛在的裂痕。這一切都以真誠的調頻完成。

E. 讓介入更個人化的困難

E1. 標記與做法

- 標記：受督者談到偏好使用某個介入而非另一個，或想調整治療步驟，使之更符合自己的個人價值。這最終有助於傳達真誠，並變得真實而一致。在這個歷程中，受督者表達需要把自己的人格融入不同的介入模式，督導者則促進受督者探索個人化的介入方式，使受督者發展出個人風格。
- 原書示例：受督者可能說，以較試探的方式開始雙椅對話，並給個案一些準備，會比更直接地請個案「毫無預警地」演出自己的批評面「感覺比較好」。這時督導者探索調整雙椅步驟的替代方式。督導者的角色，是鼓勵受督者自由選擇督導中要處理什麼，以及何時、如何處理。

E2. Exhibit 5.5：個人化困難的任務（改寫重構）

成分	內容
標記	受督者談到偏好某個介入；想調整介入以符合個人風格；督導者注意到受督者不太敢說出對任務執行方式的偏好
任務環境：澄清	鼓勵受督者以具體例子表達對個人風格的需要
任務環境：探索替代方式	邀請受督者公開談論偏好的介入，促進對話：為什麼偏好、對受督者與個案可能的好處；提供治療任務在何時、做什麼、如何做上的替代方式；鼓勵受督者自由選擇，同時提供足夠的引導與支持
任務環境：同理反映與驗證	持續支持受督者把人格融入介入、找到個人風格；以不評判的方式指出受督者可能的脆弱或個人困難領域，並回饋日後如何處理；承認並驗證受督者是自己作為治療師之經驗的專家

成分	內容
受督者歷程	反思處理個案議題的個人偏好，並把它們連回 EFT 原則；權衡使用不同介入的利弊；嘗試不同的關係與介入方式；練習自我覺察，監測自己對不同介入的情緒反應，直到開始形成「感覺對了」的感覺；持續強調個人的優勢與技能；學會在當下覺察，並降低對個案議題的負面情緒反應；達到個人風格與和個案後設溝通的整合，以達成最佳治療效果
解決	受督者感到被鼓勵、被啟發，以個案為念發展個人的介入風格

F. 本章結論

原教材指出，在 EFT 督導中，督導者給予非常具體、逐刻的技術回饋。儘管技術焦點很高，仍要強調：關係仍被視為助人歷程的根本與基礎。督導始終關注督導者與受督者之間，以及治療師與個案之間的關係。

因為督導者提供大量關於「可以怎麼做不同」的回饋，若沒有一段被經驗為真誠而接納的高度支持性關係，受督者可能會感到被批評。前述示例中，治療師在 EFT 上已經進階，需要的是精煉技能，而不是手把手的陪伴；督導者透過溝通並最終承認自己的誤解，預防了潛在的裂痕。這一切都以真誠的調頻完成。

G. 理論架構：技術困難的分類與任務

困難	標記（簡述）	任務環境的核心	解決
個案概念化	不清楚、卡住、漏掉核心基模	澄清 → 概念理解 → 任務探索；書面概念化	把逐刻歷程凝鍊為基模理解，並能向個案傳達焦點
概念困難	不理解任務概念或程序	補理論、回答問題、看錄影、作業	概念清楚，連結閱讀與臨床
知覺困難	聽不見情緒、錯過線索	逐刻暫停、找微標記、練習「成為個案」、量表練習	能辨識並區分標記，並能類推
行動困難	不知道下一步、卡住	具體例子、「可以做」、逐刻探索、練習、帶回結果	越來越熟練、流暢
個人化困難	偏好、想調整、不敢說	澄清、探索替代方式、驗證	以個案為念，發展個人風格

從臨床實務角度：同一個「卡住」，可能屬於不同類別。例如「我不知道怎麼讓個案說出憤怒」可能是：

- 概念困難：不理解為什麼要活化憤怒；
- 知覺困難：沒聽出憤怒的線索；
- 行動困難：知道也聽到，但不知道怎麼說；
- 受督者自身的恐懼：害怕深化。

正確分類，決定督導要給什麼。

H. 實證基礎

主張	證據性質	強度與限制
特定介入歷程可預測較佳結果	Greenberg (2010) 整理的歷程—結果研究	支持「符合模式地執行介入」的重要性；本章未說明具體研究
第一層 vs. 第二層批評	臨床理論與督導經驗	本章未引用研究
先憤怒後悲傷	督導者明確標示為假設	屬於臨床假設，不宜當作通則
依核心需求決定換椅時機（依附 vs. 受虐）	臨床理論	未引用研究
受督者克服恐懼有助個案克服恐懼	臨床觀察與理論	未提供研究支持
各 Exhibit 中的受督者歷程	作者整理	第7章承認受督者學習歷程仍是最少被研究的環節

I. 臨床意義

面向	本單元的意涵
概念化	以受督者的「觸動」為羅盤；把次發的絕望與核心痛苦分開；概念化要逐步修正，保留替代路徑；等清楚的標記出現再介入
介入	介入是手段，不是目的；多重標記時以核心痛苦決定方向；無法用指令取得感受；要創造經驗，不只提供洞察
雙椅	取得第一層批評；讓批評具體；把中斷變成「在做」
空椅	先建立經驗性接觸；問「此刻感覺到什麼」；先憤怒再悲傷，而且在當下；「我」語言；依核心需求決定換椅時機
羞愧揭露	下次晤談主動提起，感謝信任；迴避會證實「羞恥到無法談」
受督者自身	正常化自我批評並肯定能力；驗證對深化的恐懼；個人工作在督導之外
個人化	鼓勵受督者發展個人風格，但要回到 EFT 原則檢驗
督導關係	技術回饋越多，越需要高度支持的關係

J. 臨床推理：受督者說「我卡住了」

1. 應蒐集的資訊：卡在哪一段錄影？卡住時受督者在想什麼、感覺什麼？
2. 可能的假設：
3. 概念困難：不懂為什麼要這樣做；
4. 知覺困難：沒看到標記；
5. 行動困難：不知道怎麼做；
6. 概念化困難：不知道核心是什麼；
7. 受督者的恐懼或自我批評。
8. 替代解釋：個案的準備度不足（標記尚未成熟），受督者的「卡住」其實是適當的等待；或是同盟的問題（見單元4）。
9. 支持或削弱各假設的資料：
10. 受督者能不能說出這個任務的目的？（檢驗概念）
11. 聽錄影時能不能指出標記？（檢驗知覺）
12. 能不能說出一句下一步的回應？（檢驗行動）
13. 描述時有沒有明顯的焦慮或自我批評？（檢驗恐懼）
14. 下一步：依分類選擇 Exhibit 5.1–5.5 的任務環境。

K. 常見誤解與臨床陷阱

1. 把雙椅或空椅當成練習真實對話的角色扮演。
2. 追著罪惡感走，而不是追著最觸動的時刻。
3. 把次發的絕望當成核心。
4. 執著於找到「正確的介入」，失去個案的經驗。
5. 停在第二層批評（「你為什麼不表達？」）。
6. 讓批評者停在洞察（「我先貶低你，別人就不會」），而不是具體地演出。
7. 太早取用憤怒，在個案還沒有任何憤怒線索時。
8. 提供理解與摘要，而不是創造經驗。
9. 把中斷經驗為「被做」，而不是「在做」。
10. 空椅從敘事開始，而不是從經驗性接觸開始。
11. 使用評價性語句（「聽起來很表面」）。
12. 問「你那時感覺什麼」而不是「你現在感覺什麼」。
13. 在個案抱怨時換椅，造成辯論。
14. 強化拒斥性的憤怒（「真可悲」），而不是引導為「我很生氣」。
15. 沒有清出憤怒就去找悲傷。
16. 在依附渴望的核心下，以憤怒作為換椅時機（除非涉及虐待）。
17. 迴避個案的羞愧揭露。
18. 在督導中對受督者做治療，而不是轉介。

19. 只給技術回饋，忽略關係的支持。

L. 倫理、文化與專業考量

- 深化前的禁忌檢查：督導者在鼓勵深化之前，先確認沒有禁忌。從臨床實務角度，這包括目前的危機與自殺風險、解離、物質使用、生活的穩定度，以及晤談結束時的安全。
- 督導與治療的界線：受督者的自我批評與恐懼，在督導中只在認知層次拆解或同理探索；更深的個人工作在訓練或治療中進行，需要時轉介。
- 羞愧與家庭秘密的揭露：以尊重、感謝信任的方式回應；從臨床實務角度，若揭露涉及兒童受到性剝削或虐待，需評估是否涉及通報義務。
- 扮演負面他人的風險（從臨床實務角度）：讓個案演出責怪或忽視的父母，可能喚起強烈的痛苦，要在同盟穩固、個案準備好時進行，並注意晤談結束前的情緒調節。
- 個人化與模式忠誠度：個人風格要回到 EFT 原則檢驗，以維持介入的有效成分。
- 文化（從臨床實務角度）：「對父母說『我很生氣』」在某些文化中可能特別困難，需要配合許可的給予與個案的價值（見單元1、4）。

M. 學習者必須帶走的核心知識

層次	內容
必須記住	三大技術困難領域；介入困難三類；五個 Exhibit 的標記、任務環境、歷程與解決；第一層與第二層批評；空椅的十三條微技巧原則
應該理解	介入是手段；無法用指令取得感受；經驗 vs. 洞察；受督者恐懼與個案恐懼的循環；關係支持與技術回饋的關係
能夠應用	分類「卡住」；把第二層批評帶到第一層；空椅中間「現在感覺到什麼」；引導「我」語言；依核心需求決定換椅時機
能夠批判性思考	「先憤怒後悲傷」是假設；扮演負面他人的風險；受督者歷程缺乏研究；個人化與模式忠誠度的平衡

§3 核心概念洞見

洞見一：「卡住」要先分類，才知道要給什麼

- 核心命題：受督者的技術困難可分為概念化、概念、知覺、行動與個人化五類，各有不同的任務環境。同一句「我卡住了」，背後的需要可能完全不同。
- 臨床重要性：對知覺困難的受督者講理論，或對概念困難的受督者示範技巧，都無法解決問題。
- 對臨床推理的影響：督導者（以及受督者自己）先問：「我是不懂為什麼、沒看到、不知道怎麼做，還是害怕做？」

- 例子：受督者說「我不知道怎麼讓個案說出憤怒」。一聽錄影，發現他根本沒聽出個案語氣中的怨恨。這是知覺困難，需要逐刻暫停練習，而不是教步驟。
- 常見學生誤解：以為所有技術困難都是「技巧不夠」。
- 教學重點：先分類，再給任務。

洞見二：介入是手段，核心痛苦才是目的

- 核心命題：標記引導的方法容易讓治療師執著於「正確的介入」。原教材強調，只要抵達核心感受與需求，用哪個介入、跟隨哪個標記並不那麼重要。
- 臨床重要性：晤談中常同時出現多個標記，執著於選對介入會讓治療師離開個案的經驗。
- 對臨床推理的影響：多個標記同時出現時，問：「哪一條路最能通往這位個案的核心痛苦？」而不是「哪一個才是正確的任務？」
- 例子：個案同時出現未竟事務、自我厭惡與自我中斷的標記。治療師回到跟隨個案的痛苦，最後抵達她對接納與驗證的需求。
- 常見學生誤解：以為任務選錯就是失敗。
- 教學重點：跟著痛苦走，介入只是路。

洞見三：要創造經驗，不只提供理解

- 核心命題：治療師無法用指令取得感受，只能促進其浮現；個案需要自我組織，以新的方式經驗自己，而不是理解某件事。摘要與詮釋很好，但不足以帶來改變。
- 臨床重要性：新手最常見的傾向，是用解釋與洞察代替經驗。例如告訴個案「你會依別人的反應阻止自己」，而不是讓個案在椅子上演出自己如何阻止自己。
- 對臨床推理的影響：每次想解釋時，問自己：「我能不能讓他在這裡、現在，經驗到這件事？」
- 例子：個案說「我好像忘了要說什麼」，治療師不去解釋這是逃避，而是請她換椅子，演出讓自己忘記的那個部分，把「被做」變成「在做」。
- 常見學生誤解：以為個案「懂了」就是改變。
- 教學重點：把洞察變成此時此地的經驗。

洞見四：受督者的恐懼，會變成個案的天花板

- 核心命題：受督者害怕深化，會限制個案能抵達的深度；受督者克服自己的恐懼，則能幫助個案發現自己不會崩潰。這是循環的歷程。但處理受督者深層的恐懼，屬於訓練或個人治療，而不是督導。
- 臨床重要性：這解釋了為什麼許多技術問題最後回到治療師自己。
- 對臨床推理的影響：受督者說「我不想推個案」時，督導者先確認沒有禁忌，驗證恐懼，再協助受督者停留在情緒中；需要時提出個人工作的選項。
- 例子：受督者害怕請個案做自我中斷工作，因為擔心失去個案。督導者先驗證這份害怕，再一起確認個案的穩定度，並練習如何溫和地邀請。
- 常見學生誤解：以為不深化就是保護個案。有時候這保護的是治療師自己。
- 教學重點：治療師面對過自己的痛苦，才更能陪個案面對痛苦。

洞見五：空椅的力量在「此刻」與「順序」

- 核心命題：空椅對話的關鍵是把敘事帶到當下：先建立經驗性接觸；問「你說這句話時，現在感覺到什麼」；把拒斥性憤怒轉為「我」語言；先憤怒再悲傷；依核心需求（依附或受侵犯）決定換椅時機。
- 臨床重要性：許多空椅對話停在說故事或辯論，沒有觸及原發情緒與需求。
- 對臨床推理的影響：在空椅中持續問：「她現在在講過去，還是在經驗此刻？她的憤怒是『你……』還是『我……』？她的核心需求是親近，還是界線？」
- 例子：個案說「我覺得被忽視」，但語調充滿怨恨。治療師問：「你說這句話時，現在感覺到什麼？」個案說：「我很生氣。」接著：「告訴她『我很生氣』。」
- 常見學生誤解：以為讓個案扮演對方、說出對方會怎麼回應，就是空椅。那可能只是一場辯論。
- 教學重點：先憤怒，再悲傷，而且在當下。

§4 關鍵原文引述

引述一

原文：

“The intervention is a means to getting to the core emotion, not an end in itself.”

中文意譯：「介入是抵達核心情緒的手段，本身不是目的。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 5, Intervention Flexibility, p. 121.

臨床意義：這句話矯正了標記引導方法的常見副作用：過度專注於選對介入。它把治療的焦點拉回個案的核心情緒。

教學意義：碩士生學了七種標記與任務後，容易把治療變成「辨識 → 套用」。這句話提醒：任務只是工具，跟隨個案的痛苦才是方向。

引述二

原文：

“The therapist cannot access feelings by instructing them; the therapist has to follow and facilitate their emergence.”

中文意譯：「治療師無法用指令取得感受；治療師必須跟隨，並促進感受的浮現。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 5, Leading and Teaching, p. 125.

臨床意義：這句話說明為什麼「你有沒有一些憤怒？」這樣的問句常常沒有效果：感受不能被要求出現，只能在適當的歷程中浮現。

教學意義：學生可以用這句話檢視自己的回應：我是在要求個案感覺，還是在創造讓感受浮現的條件（例如請個案演出讓自己害怕的那一方）？

引述三

原文：

“The stories are good at first because they get at the feeling, but they don’t bring her to the present.”

中文意譯：「故事一開始是好的，因為它們觸及感受；但它們不會把她帶到當下。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 5, Difficulties With Marker Identification and Microskills in Unfinished Business（督導示例中的督導者語句），p. 135.

臨床意義：這句話精準說出敘事與經驗的差別：故事能帶出感受的線索，但改變發生在個案此刻正在經驗的情緒中。

教學意義：空椅或任何情緒工作中，學生可以練習一個簡單的轉換：從「那時候你感覺什麼？」轉到「你說這句話時，現在感覺到什麼？」

§5 臨床推理框架

5.1 分類受督者的技術困難

受督者的說法（示意）	可能的類別	檢驗方式	對應任務環境
「我不知道這個個案的核心是什麼。」	個案概念化	能否說出最觸動的時刻？	Exhibit 5.1：澄清、概念理解、任務探索；書面概念化
「為什麼要活化批評者？」	概念	能否說出任務的目的與步驟？	Exhibit 5.2：補理論、看錄影、作業
「我聽不出她底下的情緒。」	知覺	聽錄影時能否指出標記？	Exhibit 5.3：逐刻暫停、成為個案、量表練習
「我不知道接下來要做什么。」	行動	能否說出一句下一步的回應？	Exhibit 5.4：具體例子、「可以做」、練習、帶回結果
「我比較想用試探的方式開始雙椅。」	個人化	是否仍符合 EFT 原則？	Exhibit 5.5：澄清、探索替代方式、驗證
「我不敢推他。」	受督者的恐懼	有沒有禁忌？恐懼的內容是什麼？	驗證、停留、覺察恐懼；需要時轉介

受督者的說法（示意）	可能的類別	檢驗方式	對應任務環境
「我是不是很爛？」	受督者的自我批評	持續或偶發？	正常化、肯定；認知層次拆解；需要時轉介

5.2 雙椅中的推理

問題	做法
批評者說的是第一層還是第二層？	第二層（批評自己有問題）→ 找出阻止個案的核心批評
批評夠具體嗎？	從「我先貶低你」這種洞察，轉為具體情境的演出
第一層批評包含什麼？	負面評價 + 嚇唬自己，兩者都要發展
個案此刻有憤怒的線索嗎？	沒有 → 不要取用憤怒，先讓個案演出讓自己害怕的一方
出現中斷了嗎？	把「被做」變成「在做」，請個案演出中斷
我在提供理解，還是創造經驗？	若是理解，轉入對話

5.3 空椅中的推理（依順序）

步驟	問題	做法
1	建立經驗性接觸了嗎？	「你看得到她嗎？看到她時，你感覺到什麼？」
2	個案在敘事還是在經驗？	「你說這句話時，現在感覺到什麼？」
3	內容與語調一致嗎？	內容「被忽視」、語調怨恨 → 引向憤怒
4	憤怒是拒斥性還是賦能的？	「真可悲」→「告訴她你氣什麼」「我很生氣你」
5	憤怒清出來了嗎？	先憤怒 → 再問「現在感覺到什麼」→ 悲傷
6	需求是什麼？	憤怒中的表層需求 → 悲傷中的深層需求與思念
7	何時換椅？	早期：「當那個忽視你的媽媽」；後期：「媽媽怎麼回應你的感受和需要？」 不要在抱怨或憤怒時換椅（除非涉及虐待）
8	核心需求是親近還是界線？	親近 → 悲傷與「我需要你」；受虐 → 憤怒作為界線

5.4 概念化推理：以本章示例為例

問題	本章示例中的答案
受督者最被什麼觸動？	「像被剪了翅膀的鳥」：被困住
哪些是次發情緒？	無望（症狀性）
暫定的核心是什麼？	不可愛：焦慮不安全，還是羞愧？
新資料如何修正？	追隨活力感受時的困惑與不安全；無法把情緒當資訊
何時處理可能的未竟事務？	等清楚的標記出現
最後的核心？	焦慮不安全（源於焦慮的母親）
替代路徑？	若罪惡感更強 → 對母親憤怒的自我中斷

5.5 督導關係的推理

技術回饋越多，越要檢查關係：受督者感到被支持嗎？督導者有沒有誤解？必要時承認自己的誤解。對進階受督者，重點是精煉；對新手，則需要更多陪伴與支持。